

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 15:05:12

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Venancio Enrique Fernández Berríos
Edad : 46a 8m 7d
Dirección : Radal 640. San Carlos

Rut : 12.900.940-3
Fecha Nacto: 01/10/1975
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0220795
Sexo : Masculino
Teléfono : 996932301

N° Epicrisis
308552

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/05/2022 11:54

Días Estadía: 35

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 08/06/2022 09:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Status epiléptico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 04/05/2022
FI UPC: 04/05/2022
FI Sala: 25/05/2022

Paciente diestro. mRankin 3 (uso de bastón) con los siguientes antecedentes::

- Mórbitos: Epilepsia 2° a daño estructural (Traumatismo encefalocraneano (TEC) el 2017), Diabetes Mellitus (DM) 2 ni insulino requiriente, luxación recurrente de hombro izquierdo (disyunción acromioclavicular). Múltiples hospitalizaciones y consultas en servicio de urgencias por episodios consultivos (última el 01/05 tras problemas con retiro de Levetiracetam).
- Quirúrgicos: Craniectomía descompresiva bifrontal + evacuación de hematoma en 2017 (estadía UCI).
- Fármacos: Levetiracetam 2 gramos cada 12 horas, Diazepam 5 mg cada 12 horas, Risperidona 1 mg/noche, Metformina 850 mg cada 12 horas.
- Alergias: Fenitoína (anafilaxis).
- Hábitos: OH suspendido hace 4 años, TBQ no, drogas (+) PBC.
- Hospitalizaciones: 2017 TEC con hematoma bifrontal, 2018 status convulsivo y hematoma extradural laminar, 2020 y 2021 status convulsivo.

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos. Fue encontrado el día de ingreso comprometido de conciencia a las 08:30 horas, última vez visto en buenas condiciones el 03/05 durante la noche. Fue trasladado tras 90 minutos de ser encontrado, directamente a reanimador, donde se describió sin control de secreciones, ventilando simétrico, bien perfundido, con sangre seca en región frontotemporal izquierda, Glasgow 6, sin focalidad neurológica, HGT 109 mg/dL. Durante estadía en servicio de urgencias presentó episodio de convulsión tónico clónico generalizada que fue yugulada con Lorazepam 4 mg. Se mantuvo en sopor profundo, sin protección de vía aérea, por lo que, fue evaluado junto a neurología, se cargó con Levetiracetam 2 gramos y Ácido valproico 1800 mg. Se procedió a intubación orotraqueal (IOT). Al laboratorio inicial destacó pH 7.1, CO2 36.7, HCO3 11.2, PCR 11, Hemoglobina 16.3, Leucocitos 20.550, plaquetas 206.000, INR 1.2, ácido láctico 96, creatinina 0.93, BUN 12, FA 96, GOT 136, GPT 57, CK total 19965, CK MB 375, LDH 712. Se realizó tomografía computada (TC) de tórax que mostró signos sugerentes de neumonía aspirativa. Ingresó a Unidad de paciente crítico (UPC) para continuar monitorización y tratamiento.

Diagnósticos de ingreso a UPC:

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 15:05

Página 1 de 4

- Status epiléptico convulsivo.
- Neumonía aspirativa.
- Acidosis láctica (obs 2° a Metformina).
- Antecedentes: Epilepsia 2° a TEC, DM2 NIR, disyunción acromioclavicular.

Evolución

1) Neurológico:

Paciente con antecedente de epilepsia estructural 2° a TEC grave, que requirió craniectomía descompresiva por hematoma bifrontal, además de hospitalización prolongada. Ingresó por nuevo status convulsivo prolongado, de al menos 2 horas de evolución que impresionó secundario a irregular adherencia a fármacos (suspensión de Levetiracetam y de Diazepam en las últimas 2 semanas).

Posterior a carga de fármacos antiepilépticos se ajustó de forma progresiva fármacos anticonvulsivantes, se disminuyó dosis de levetiracetam por ajuste por función renal dado falla renal aguda, se mantuvo 500 mg cada 12 hrs. Se inició Ácido Valproico, llegando a dosis de mantención de 1 gramo cada 8 horas y se ajustó Diazepam en dosis de 5 mg cada 12 horas. Se realizó último electroencefalograma el 18/05 informado esporádica actividad epileptiforme interictal bifrontal independiente, lentitud continua bifrontal, disfunción lenta continua generalizada reactiva. Además evolucionó en UPC con tetraparesia de 4 extremidades compatible con mioneuropatía de paciente crítico

Paciente se trasladó a sala de neurología el 25/05 donde evolucionó estable, sin nuevos eventos sugerentes de crisis. Se aumentó dosis de levetiracetam a dosis habituales, dado mejoría de función renal. Se controlaron niveles plasmáticos de Ácido Valproico en 53.1 (en rango) el 27/05 (últimos).

En sala de neurología evolucionó con mejoría de tetraparesia hasta llegar a fuerza braquial M4 proximal y M4+ distal, crural M4+ proximal y M3+ distal.

2) Rehabilitación:

- Kinesiológico: paciente se mantuvo durante hospitalización en rehabilitación con equipo de kinesiología. Previo a traslado logró bípedo independiente, marcha sin apoyo sólo con supervisión con indicación de marcha independiente con supervisión.

- Fonoaudiológico: Inicialmente por disfagia Fils 2 se mantuvo con sonda nasogástrica, alimentándose con Diben. Se mantuvo en rehabilitación por equipo de Fonoaudiología. Previo a traslado logró retirarse sonda nasogástrica y por disfagia Fils 7 se inició régimen licuado + líquidos espesos con buena tolerancia, luego progresó a régimen blando sin granos + líquidos claros por disfagia Fils 8 con buena tolerancia.

- Terapia Ocupacional: durante hospitalización se mantuvo en rehabilitación donde se fomentó independencia en actividades básicas de vida diaria y funcionalidad de extremidades.

3) Ventilatorio:

Ingresó con diagnóstico de status epiléptico convulsivo, con indicación de protección de vía aérea, por lo que se realizó IOT. Se mantuvo con ventilación mecánica invasiva prolongada por compromiso de conciencia llegando a extubarse el 23/05 sin incidentes. Posteriormente se mantuvo con bajos requerimientos de oxígeno por naricera con buena mecánica ventilatoria que llegó a suspenderse en sala de neurología.

Evolucionó con secreciones bronquiales abundantes que se manejaron con kinesioterapia respiratoria, aspiración y bromuro de ipratropio con buena respuesta. Posteriormente con mejoría de secreciones, sin necesidad de mantener aspiraciones en las últimas 72 hrs.

4) Hemodinamia: Evolucionó inicialmente con bajos requerimientos de noradrenalina por sedoanalgesia. Posteriormente evolucionó con tendencia a la hipertensión arterial, por lo que se inició tratamiento antihipertensivo con Amlodipino e Isosorbide. En sala de neurología presentó un episodio aislado de hipotensión y taquicardia en contexto de bajo volumen que se manejó con volemicización y suspensión de medicamentos antihipertensivos con buena respuesta. Se mantuvo sólo con Isosorbide con lo que evolucionó con buen control de presiones arteriales, con leve tendencia a la hipotensión por lo que se suspendió.

5) Infeccioso: Paciente evolucionó con neumonía aspirativa con hallazgos compatibles en TC de tórax de ingreso, sin microbiología aislada. Recibió 8 días de tratamiento antibiótico con Ampicilina Sulbactam con buena respuesta. En sala de neurología evolucionó afebril, con parámetros inflamatorios bajos.

6) Renal: Evolucionó en UPC con insuficiencia renal aguda 2° a rabdomiolisis (CK total hasta 29011), con requerimiento de hemodiálisis en 2 ocasiones (09/05 y 11/05). Posteriormente evolucionó con corrección de función renal (creatinina a la baja; ingreso: 0.93- peak 8.29- actual 0.95)), diuresis conservada y CK total a la baja, sin necesidad de continuar con diálisis.

Por estabilidad clínica se decidió traslado a domicilio con unidad de hospitalización domiciliaria para continuar terapia kinésica, fonoaudiológica y terapia ocupacional.

Diagnósticos actuales:

- Status epiléptico convulsivo resuelto.
- Neumonía aspirativa tratada.
- Acidosis láctica resuelta.
- Rabdomiólisis tratada.
- Insuficiencia renal aguda resuelta.
- Mioneuropatía de paciente crítico en resolución.
- Disfagia severa FILS 2 en rehabilitación
- Trastorno de la marcha en rehabilitación
- Antecedentes: Epilepsia 2° a TEC, DM2 NIR, disyunción acromioclavicular.

Contacto familiar, tutor: 996932301 (madre).

Diagnóstico de Egreso

Status Epiléptico Resuelto - 2° Suspensión De Diazepam
Rabdomiolisis Resuelta -
Insuficiencia Respiratoria aguda parcial -
Insuficiencia Renal Aguda - En Resolución
Neumonía Aspirativa - Tratada
Delirium Hipoactivo -
Miopatía Del Paciente Crítico -
Epilepsia Estructural 2° A Tec Grave Complicado -
Diabetes mellitus 2 -
Disfagia Severa Fils 2 En Rehabilitación -
Trastorno De La Marcha En Rehabilitación -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Examen Físico general:

SV: PA 91/67 mmHg (PAM 75), T° 36°C, FC 89 lpm, Sat 94% amb, HGT 78 mg/dL.

- Hidratado, bien perfundido
- RR2T no ausculto soplos, MP (+) con ruidos bronquiales leves.
- Abdomen BDI, RHA (+) no palpo masas.
- EEII sin edema, sin signos de TVP.

Examen Neurológico:

- Vigil, orientado en tiempo y espacio, atento (invierte series simples), disartria leve, sin afasia.
- PC: sin alteraciones.
- Paresia braquial M4 proximal bilateral y M4+ distal bilateral. Crural M4+ proximal y M4- distal bilateral. Plantares flexores.
- Sensitivo: refiere conservado.
- Cerebeloso no evaluable.
- Signos meníngeos (-)

Plan Post Alta

1) Medidas generales:

- Reposo relativo, marcha independiente con supervisión.
- Régimen blando sin granos + líquidos claros.
- Continuar Rehabilitación por kinesiólogía, fonoaudiología y terapia ocupacional

2) Fármacos:

- Ácido Valproico 250 mg, 4 comprimidos cada 8 horas, vía oral, a permanencia.
- Levetiracetam 500 mg, 4 comprimidos cada 12 horas, vía oral, a permanencia.
- Diazepam 10mg, 1/2 comprimido cada 12 horas, vía oral, a permanencia.

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 15:05

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 15:05:12

- Bromuro de ipratropio, 2 puff cada 6 horas con aerocámara. .
- Polietilenglicol, 15 gramos c/12 horas, vía oral. Ajustar según deposiciones.

3) Exámenes:

- Controlar pruebas hepáticas, niveles plasmáticos de ácido valproico, creatinina.

4) Controles:

- Control ambulatorio con Neurología equipo de Epilepsia, solicitar hora en CDT pasillo 9.
- Consultar en caso de necesidad en servicio de urgencias.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bernardita Ramos Merello

Becado/Residente

Amada Marcela Espinosa Maramb

Médico Tratante (Staff)